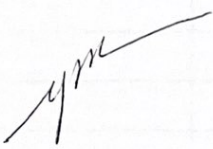


BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI



VÌ MỘT TRÁI TIM KHỎE

**QUY TRÌNH
ĐÓN TIẾP BỆNH NHÂN
VÀ KHÁM CHỮA BỆNH NGOẠI TRÚ
TẠI KHU TỰ NGUYỆN 1 CƠ SỞ 1
QT.25.01**

	Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Hải Yến	Nguyễn Thị Thu Thủy	Nguyễn Sinh Hiền
Ký			  GIÁM ĐỐC Nguyễn Sinh Hiền

I. MỤC ĐÍCH:

Quy định thống nhất quy trình đón tiếp và khám chữa bệnh ngoại trú cho mọi đối tượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh Tự nguyện Bệnh viện Tim Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho người bệnh đến khám bệnh một cách nhanh chóng, thuận lợi và an toàn.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với tất cả các đối tượng bệnh nhân đến khám bệnh và điều trị ngoại trú tại khu Khám bệnh Tự nguyện 1 Cơ sở 1.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

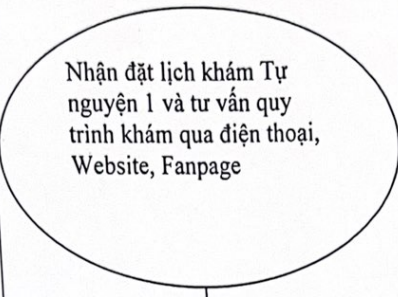
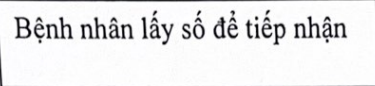
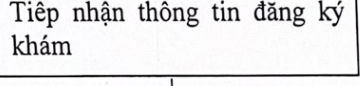
Quy chế bệnh viện – Nhà xuất bản Y học năm 1997

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT**4.1 Thuật ngữ: không****4.2 Từ viết tắt: không**

- BHYT: Bảo hiểm y tế.
- BN: Bệnh nhân
- CCCD: Căn cước công dân
- CLS: Cận lâm sàng
- HA: Huyết áp
- XN: Xét nghiệm
- BVT: Bệnh viện Tim
- XQ: X – Quang
- KQ: Kết quả
- TKQ: Trả kết quả
- HS: Hồ sơ
- Bs: Bác sĩ
- ĐD: Điều dưỡng
- TS: Tiến sỹ
- Ths: Thạc sỹ
- DHST: Dấu hiệu sinh tồn
- HDV: Hướng dẫn viên

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Sơ đồ đón tiếp và khám chữa bệnh ngoại trú Tự nguyện 1 tại cơ sở 1 - Bệnh viện tim Hà Nội:

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
Nhân viên tổ chăm sóc khách hàng – phòng Công tác xã hội		Bệnh nhân tiếp cận với thông tin đặt lịch trên giấy hẹn khám lại, bì hồ sơ khám và trên các trang thông tin điện tử để đặt lịch đăng ký khám chọn bác sĩ tại khu khám Tự nguyện 1. BN đặt lịch được nhân viên tư vấn và thông báo thông tin đã đặt khám gồm: mã đặt lịch (số thứ tự tiếp nhận), ngày khám và bác sĩ khám (nếu có). BN không đặt lịch đến lấy số trực tiếp tại cây lấy số tự động khu Tự nguyện 1
Nhân viên tổ tư vấn và tiếp đón khám bệnh – Hướng dẫn viên		- BN đã đặt lịch khi đến khám vào thang quầy tư vấn dành cho bệnh nhân đã đặt lịch trước và thông báo thông tin đã đặt lịch khám cho nhân viên tư vấn để làm thủ tục đăng ký khám. - BN không đặt lịch trước đến lấy số thứ tự tại cây lấy số tự động và ngồi chờ gọi theo số thứ tự đã lấy. HDV hướng dẫn BN khu vực lấy số và ổn định trật tự khu vực chờ tiếp nhận
Nhân viên tổ tư vấn và tiếp đón khám bệnh.		Bệnh nhân đăng ký khám bệnh Tự nguyện 1 gồm các đối tượng: bệnh nhân có BHYT và không có BHYT; tái khám và khám mới. - Bệnh nhân khám lần đầu khai thông tin vào phiếu đăng ký khám bệnh. - Hướng dẫn BN khám BHYT xuất trình giấy chuyển viện, giấy hẹn khám lại, thẻ BHYT (trong trường hợp không mang thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh BHYT trên ứng dụng Vss – ID hoặc CCCD gắn chip có tích hợp thẻ BHYT thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy), CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, photo các giấy tờ cần thiết cho BN. - Bệnh nhân có giấy chuyển tuyến mới được hướng dẫn ký cam kết vào Giấy cam kết đồng ý chi trả khoản chênh lệch giá dịch vụ y tế trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội. - Hướng dẫn BN có BHYT chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết để thuận tiện cho nhân viên kế toán kiểm tra và tiếp nhận. - Đề nghị tất cả bệnh nhân đăng ký khám xuất trình CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác (nếu có)

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
		đề đổi chiếu khi khai thông tin khám bệnh. Trường hợp không có CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác thì sau khi viết xong cho bệnh nhân kiểm tra lại thông tin trên bì hồ sơ khám bệnh. Bìa hồ sơ khám bệnh ghi đầy đủ các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ (tối thiểu từ tuyến xã/phường), số điện thoại. - Tên bác sĩ bệnh nhân lựa chọn khám được ghi ngoài sổ để nhân viên phân phòng phát sổ vào phòng khám của bác sĩ đó. - Những BN thuộc đối tượng ưu tiên (theo quy định số 154 của BVT ban hành ngày 12/01/2024) sẽ được nhân viên đóng dấu "ưu tiên" lên trên sổ khám. - Hướng dẫn BN sang các quầy kế toán theo đối tượng (quầy dành cho BN ưu tiên và đặt lịch khám, quầy dành cho BN không ưu tiên và chưa đặt lịch khám).
Nhân viên kế toán	Thực hiện thu phí và tiếp nhận BHYT (nếu có) 	- BN có BHYT xuất trình các giấy tờ cần thiết (giấy chuyển viện, giấy hẹn khám lại, thẻ BHYT hoặc ứng dụng Vss – ID hoặc CCCD gắn chip có tích hợp thẻ BHYT). - Nhân viên kế toán thông báo cho bệnh nhân phí khám, phí chênh lệch BHYT (nếu có) và thực hiện thu phí. - Hướng dẫn BN sang bàn đo dấu hiệu sinh tồn, chiều cao, cân nặng.
Nhân viên đo dấu hiệu sinh tồn	Thực hiện đo dấu hiệu sinh tồn, chiều cao, cân nặng cho bệnh nhân 	Tại bàn đo dấu hiệu sinh tồn, chiều cao, cân nặng: - Nhân viên thực hiện đo DHST, chiều cao cân nặng và ghi vào phiếu tiếp nhận bệnh nhân - Ưu tiên thực hiện cho những bệnh nhân thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định. - Nhân viên thực hiện theo quy trình đo DHST đã được đào tạo. - Các trường hợp bất thường báo bác sĩ hoặc chuyển cấp cứu (HD.25.01). - Có thể linh hoạt đo huyết áp trước hoặc đóng tiền trước tùy theo lượng bệnh nhân để tránh ùn tắc

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
Điều dưỡng, HDV tại bàn phân phòng - Trả kết quả	Thực hiện hướng dẫn BN đi làm các chỉ định CLS và tổng hợp kết quả trước khi phát số cho BN vào kết luận 	- Điều dưỡng phát số phân phòng cho BN chưa được khám và hướng dẫn BN về khu vực chờ khám theo số thứ tự. - Với BN đã có chỉ định cận lâm sàng, DD hướng dẫn BN các mục phải làm: + Bước 1: nhân viên ghi số thứ tự lên các phiếu chỉ định và phiếu thu tiền của BN. + Bước 2: Nhân viên tích các mục BN phải làm, vị trí làm vào phiếu hướng dẫn để bệnh nhân nắm được quy trình và tất cả chỉ định sẽ phải hoàn thiện trước khi gặp bác sĩ kết luận. Nhân viên trả lại phiếu thu có kẹp phiếu hướng dẫn cho BN. + Bước 3: HDV đưa BN đi làm các chỉ định CLS: siêu âm tim, siêu âm bụng mạch, XQ, điện tim, ABI... và lấy kết quả về. - Quan sát bệnh nhân khu vực ngồi chờ và ổn định chỗ ngồi, hướng dẫn BN quy trình làm các chỉ định tiếp theo - HDV tại các vị trí được phân công chuyển kết quả CLS của BN về bàn trả kết quả để điều dưỡng kiểm tra và ghim vào hồ sơ khám bệnh. + Bước 4: Điều dưỡng kiểm soát kết quả CLS. Điều dưỡng chuyển cấp cứu các trường hợp bất thường theo HD.25.01. Các trường hợp bất thường khác điều dưỡng xin ý kiến bác sĩ hoặc phát số ưu tiên cho BN vào gặp bác sĩ. - Các trường hợp đủ kết quả được phát số, trả số và hướng dẫn ngồi chờ vào phòng khám bác sĩ kết luận
HDV hành lang	Hướng dẫn BN và ổn định khu vực BN ngồi chờ khám và chờ làm các chỉ định CLS 	- Hướng dẫn BN ngồi ở sảnh chờ theo số phòng khám của bác sĩ đã đăng ký. Hướng dẫn BN chú ý màn hình điện tử và loa gọi số để vào phòng khám khi được gọi: Màn hình điện tử hiện thị số thứ tự khám với 4 chữ số trùng với số khám của BN (số đầu là số phòng khám, các số tiếp theo là số thứ tự). - HDV có trách nhiệm quan sát BN, báo lại điều dưỡng bàn Trả kết quả các thông tin bác sĩ báo lại, các trường hợp hồng phần mềm, hồng máy gọi số, trường hợp BN thắc mắc ngoài khả năng giải quyết hoặc các trường hợp bất thường khác
Bác sĩ tại các phòng khám	Khám bệnh và kê đơn 	- Bác sĩ tại các phòng khám: - Gọi lần lượt theo số khám trên phần mềm gọi số. - Thực hiện khám bệnh, kê đơn trên hệ thống phần mềm khám bệnh:

rách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
		+ Bác sĩ khai thác đủ thông tin, bao gồm: dịch tễ học, bệnh sử, triệu chứng cơ năng và thực thể. + Giải thích về tình trạng bệnh tật, giải thích sự cần thiết của các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết phải làm để chẩn đoán bệnh. Bác sĩ tích và in phiếu các xét nghiệm cận lâm sàng (nếu có). + Giải thích về tình trạng bệnh tật và kê đơn thuốc cần thiết và phù hợp với tình trạng người bệnh theo đúng quy chế kê đơn (nếu có). Kê đơn thuốc cần thông báo/tư vấn với BN về loại thuốc và giá thuốc khi kê đơn để có sự thống nhất của BN. + Hướng dẫn cách sử dụng thuốc, chế độ ăn uống, tập luyện và theo dõi trong quá trình điều trị. + Thông báo lịch khám lại và các lưu ý nếu cần làm xét nghiệm cận lâm sàng cho lần khám sau (nếu có). + BS cấp giấy hẹn khám lại cho BN có ghi rõ ngày khám, giờ khám. Với BN có BHYT bác sĩ chọn mã hồ sơ trên phần mềm khám bệnh phù hợp với chẩn đoán bệnh và chẩn đoán giấy chuyển của BN (theo HD.25.01). + Bác sĩ ghi rõ lý do và ký tên bên cạnh các trường hợp cần chuyển Điều trị ban ngày hoặc Cấp cứu. Khoa điều trị ban ngày hoặc cấp cứu có trách nhiệm xử trí, giải thích hướng điều trị, kê đơn hoặc cho bệnh nhân vào viện tùy theo tình trạng bệnh nhân. + Bác sĩ giải thích tình trạng và in phiếu vào viện nếu BN cần nhập viện điều trị. + Bác sĩ giải thích tình trạng cho người bệnh, xin ý kiến Ban Giám đốc và in phiếu chuyển viện nếu BN cần chuyển tuyến điều trị theo đúng quy định. + Các trường hợp BN vào viện hưởng thông tuyến bác sĩ cho vào viện là người chịu trách nhiệm quyết định các xét nghiệm được hưởng bảo hiểm sau khi kế toán chuyển đối tượng.
Điều dưỡng bàn hẹn khám lại	Đóng dấu ngoại trú hoặc chương trình quản lý bệnh mãn tính (nếu có). Hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho lần khám sau	ĐD kiểm tra đơn thuốc: đủ thuốc, đúng ngày. Đối với BN dịch vụ hướng dẫn tái khám và đi mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Đối với đơn thuốc BHYT nhân viên đóng dấu Kiểm soát BHYT vào cuối các đơn thuốc để nhân viên kế toán biết BN đã được qua bàn hẹn khám lại. Nếu trường hợp không có dấu này nhân viên kế toán mời BN quay lại bàn hẹn khám lại để kiểm tra đóng dấu trước khi duyệt đơn. - Với BN khám BHYT chưa có hồ sơ ngoại trú:

ANH
NH
TI
HÀ

rách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
		+ Nếu BN không đủ điều kiện tham gia chương trình BHYT cả năm: Đóng dấu hẹn khám lần 2 và ngày chuyển tuyến lên giấy hẹn khám lại. + Nếu BN đủ điều kiện tham gia chương trình BHYT cả năm, đóng dấu chương trình phù hợp lên giấy hẹn khám lại và hướng dẫn BN không cần xin giấy chuyển - Với BN BHYT đã có hồ sơ ngoại trú: + Với hồ sơ ngoại trú đã khám lần 2 thì hướng dẫn BN lần tái khám sau xin giấy chuyển tuyến mới. + Với hồ sơ đang theo chương trình thì tiếp tục đóng dấu chương trình đã có vào giấy hẹn khám lại. => BN BHYT sau khi đã qua bàn hẹn khám lại được mời quay lại quầy thu tiền để duyệt bảo hiểm và ký các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục khám. * Trường hợp BN có chỉ định nhập viện, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập viện theo quy trình tiếp nhận BN nhập viện điều trị nội trú (theo QT.25.04). * Làm thủ tục cho BN chuyển tuyến, cấp giấy nghỉ ốm, liên hệ bác sĩ các trường hợp cần xin ý kiến hội chẩn
Điều dưỡng viên bàn làm thủ tục hành chính		- Nếu BN có chỉ định nhập viện, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập viện theo quy trình tiếp nhận BN nhập viện điều trị nội trú (theo QT.25.04). - Làm thủ tục cho BN chuyển tuyến, cấp giấy nghỉ ốm theo yêu cầu của bác sĩ phòng khám - Hướng dẫn và làm các thủ tục hành chính khác theo yêu cầu chuyên môn và phân công nhiệm vụ tại khoa.
Kế toán	Duyệt đơn thuốc bảo hiểm và thu phí chênh lệch (nếu có). Thu phí đơn thuốc dịch vụ ↓	Kế toán thu tiền đồng chi trả theo mức hưởng của thẻ BHYT và số tiền chênh lệch với đơn thuốc bảo hiểm (nếu có). Bệnh nhân mua thuốc dịch vụ thanh toán tiền thuốc cho kế toán tại quầy thuốc dịch vụ. Nhân viên kế toán đóng dấu đã thu tiền vào đơn thuốc và mời BN đi lĩnh thuốc BHYT hoặc mua thuốc dịch vụ
Nhà thuốc dịch vụ, quầy thuốc bảo hiểm	BN lĩnh thuốc (BHYT) hoặc mua thuốc -> kết thúc quá trình khám bệnh	- Bệnh nhân ký tên vào đơn thuốc. - Nhân viên quầy thuốc kiểm tra đơn thuốc: số lượng thuốc tương ứng với liều dùng, ngày hẹn khám. - Nhân viên khoa Dược duyệt xuất thuốc bảo hiểm với đơn thuốc hưởng BHYT - Phát thuốc theo đơn - Đóng dấu đã phát thuốc vào đơn thuốc => Bệnh nhân kết thúc quá trình khám và ra về.

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/ Tài liệu liên quan
		+ Nếu BN không đủ điều kiện tham gia chương trình BHYT cả năm: Đóng dấu hẹn khám lần 2 và ngày chuyển tuyến lên giấy hẹn khám lại. + Nếu BN đủ điều kiện tham gia chương trình BHYT cả năm, đóng dấu chương trình phù hợp lên giấy hẹn khám lại và hướng dẫn BN không cần xin giấy chuyển - Với BN BHYT đã có hồ sơ ngoại trú: + Với hồ sơ ngoại trú đã khám lần 2 thì hướng dẫn BN lần tái khám sau xin giấy chuyển tuyến mới. + Với hồ sơ đang theo chương trình thì tiếp tục đóng dấu chương trình đã có vào giấy hẹn khám lại. => BN BHYT sau khi đã qua bàn hẹn khám lại được mời quay lại quầy thu tiền để duyệt bảo hiểm và ký các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện thủ tục khám. * Trường hợp BN có chỉ định nhập viện, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập viện theo quy trình tiếp nhận BN nhập viện điều trị nội trú (theo QT.25.04). * Làm thủ tục cho BN chuyển tuyến, cấp giấy nghỉ ốm, liên hệ bác sĩ các trường hợp cần xin ý kiến hội chẩn
Điều dưỡng viên bàn làm thủ tục hành chính		- Nếu BN có chỉ định nhập viện, hướng dẫn và làm các thủ tục nhập viện theo quy trình tiếp nhận BN nhập viện điều trị nội trú (theo QT.25.04). - Làm thủ tục cho BN chuyển tuyến, cấp giấy nghỉ ốm theo yêu cầu của bác sĩ phòng khám - Hướng dẫn và làm các thủ tục hành chính khác theo yêu cầu chuyên môn và phân công nhiệm vụ tại khoa.
Kế toán	Duyệt đơn thuốc bảo hiểm và thu phí chênh lệch (nếu có). Thu phí đơn thuốc dịch vụ ↓	Kế toán thu tiền đồng chi trả theo mức hưởng của thẻ BHYT và số tiền chênh lệch với đơn thuốc bảo hiểm (nếu có). Bệnh nhân mua thuốc dịch vụ thanh toán tiền thuốc cho kế toán tại quầy thuốc dịch vụ. Nhân viên kế toán đóng dấu đã thu tiền vào đơn thuốc và mời BN đi lĩnh thuốc BHYT hoặc mua thuốc dịch vụ
Nhà thuốc dịch vụ, quầy thuốc bảo hiểm	BN lĩnh thuốc (BHYT) hoặc mua thuốc -> kết thúc quá trình khám bệnh	- Bệnh nhân ký tên vào đơn thuốc. - Nhân viên quầy thuốc kiểm tra đơn thuốc: số lượng thuốc tương ứng với liều dùng, ngày hẹn khám. - Nhân viên khoa Dược duyệt xuất thuốc bảo hiểm với đơn thuốc hưởng BHYT - Phát thuốc theo đơn - Đóng dấu đã phát thuốc vào đơn thuốc => Bệnh nhân kết thúc quá trình khám và ra về.

VIỆ
M
NỘ
★

VI. PHỤ LỤC

- BM.25.01.01: Phiếu tiếp nhận ban đầu.

BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI



BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI
HANOI HEART HOSPITAL
VÌ MỘT TRÁI TIM KHỎE

**PHIẾU TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN
KHU KHÁM BỆNH TỰ NGUYỄN**

Họ và tên BN: Năm sinh:

Ngày khám: / /20

Giờ					Ghi chú
Huyết áp (mmHg)					
Mạch (lần/phút)					
Chiều cao (cm)					
Cân nặng (Kg)					
BMI = Kg/m ²					
Nhiệt độ					

- BM.25.01.01: Phiếu hướng dẫn làm xét nghiệm.



**PHIẾU HƯỚNG DẪN LÀM XÉT NGHIỆM
KHÁM BỆNH TỰ NGUYỄN 1 (Tầng 1)**

Điện tim	Siêu âm tim	Siêu âm bụng/TG	XQuang	XN máu	Siêu âm Mạch	ABI
T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1

*Lưu ý: - Bệnh nhân ko tự ý đi làm các chỉ định Xn, sẽ có nhân viên HD và đưa dẫn Bn đi làm.
- Bệnh nhân không cần chờ lấy kết quả, kết quả sẽ được chuyển về khu chờ KBTN 1 (Tầng 1)



**PHIẾU HƯỚNG DẪN LÀM XÉT NGHIỆM
KHÁM BỆNH TỰ NGUYỄN 1**

	Điện tim	Siêu âm tim	Siêu âm bụng Tuyến giáp	Xquang	XN máu	SA mạch Thận-chi	ABI
	TẦNG	TẦNG	TẦNG	TẦNG	TẦNG	TẦNG	TẦNG
NƠI LÀM	2	2	2	1	2		1
ĐÃ LÀM							
XN KHÁC							

Lưu ý: - Bệnh nhân sẽ ngồi đợi ở sảnh chờ khu ghế sofa, không tự ý đi làm các chỉ định xét nghiệm và không tự ý xuống tầng 1. Nhân viên sẽ gọi tên theo thứ tự để mời BN đi làm xét nghiệm.
- Bệnh nhân không cần chờ lấy kết quả, kết quả sẽ được chuyển về khu chờ KBTN 1 (Tầng 2)